

1. Introducción y relevancia clínica

El **cáncer de cabeza y cuello** —que incluye cavidad oral, orofaringe, hipofaringe, nasofaringe y laringe— es una **neoplasia altamente prevenible y curable en etapas tempranas**, pero su pronóstico empeora drásticamente cuando se diagnostica tarde.

En Chile, la mayoría de los casos se detecta en **estadios avanzados (III–IV)**, cuando ya existen metástasis ganglionares cervicales o compromiso de estructuras críticas.

El **médico general o de APS** juega un rol esencial: es el primer contacto del paciente con el sistema de salud. Por eso, su capacidad para **sospechar lesiones premalignas o malignas, iniciar estudios básicos y derivar a tiempo** determina la **sobrevida y calidad de vida** del paciente.

El **Plan Nacional de Cáncer (MINSAL)** enfatiza la **pesquisa precoz, registro oportuno y derivación priorizada** como pilares de la estrategia contra el cáncer en Chile.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El **carcinoma escamoso de cabeza y cuello (CECC)** se origina a partir del epitelio que recubre la mucosa del tracto aerodigestivo superior. La **carcinogénesis** es el resultado de la exposición prolongada a **agentes carcinógenos (tabaco, alcohol, radiación, virus oncogénicos como VPH y VEB)**, que inducen **displasia progresiva** y transformación maligna.

Etapas evolutivas del daño epitelial:

1. **Mucosa normal** → exposición a irritantes.
2. **Hiperplasia y displasia leve/moderada** (reversible con eliminación del agente).
3. **Carcinoma in situ** (lesión premaligna, sin invasión).
4. **Carcinoma invasor** (infiltración del estroma, vasos o nervios).

El **intervalo promedio entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico** supera los **6 meses** en muchos casos, debido a la inespecificidad de los síntomas iniciales (disfonía, odinofagia leve, úlceras orales), que suelen ser confundidos con procesos benignos.

La **educación del personal de APS y odontología** reduce significativamente este retraso.

3. Clínica: signos de sospecha y diagnóstico diferencial

El **diagnóstico precoz** se basa en el **reconocimiento de signos clínicos persistentes**, especialmente en pacientes con factores de riesgo (tabaquismo, alcoholismo, exposición laboral, infección por VPH o VEB).

3.1 Síntomas de alarma por localización

Región	Síntoma o signo	Relevancia clínica / diagnóstico diferencial
Cavidad oral	Úlcera o placa blanca/roja >2–3 semanas, indurada o sangrante. Dolor, disfagia, halitosis.	Leucoplasia, eritroplasia, afta, liquen plano erosivo.
Orofaringe / amígdalas	Dolor o masa unilateral, odinofagia irradiada a oído, trismo, disfagia.	Amigdalitis crónica, absceso periamigdalino.
Nasofaringe	Obstrucción nasal unilateral, epistaxis, hipoacusia conductiva, masa cervical.	Adenoiditis, sinusitis, linfoma.
Laringe	Disfonía >3 semanas , tos seca, sensación de cuerpo extraño, odinofagia.	Laringitis, nódulos, reflujo.
Cuello	Adenopatía dura, fija, indolora, >2 cm, sin causa infecciosa.	Adenitis bacteriana, tuberculosis, linfoma.

☐ En APS, toda lesión mucosa persistente o disfonía prolongada debe considerarse maligna hasta demostrar lo contrario.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En nivel de Atención Primaria (APS)

El diagnóstico definitivo es histológico, pero en APS el objetivo es **sospechar precozmente y derivar con prioridad**.

Pasos del manejo inicial:

1. **Anamnesis dirigida:** duración de los síntomas, consumo de tabaco/alcohol, exposición laboral, antecedentes familiares o de VPH.
2. **Examen físico completo de cabeza y cuello:**
 - Inspección oral con buena iluminación (lengua, piso de boca, mucosa yugal, paladar).
 - Palpación bidigital del piso de boca y bordes de lengua.
 - Evaluación orofaríngea (amígdalas, paladar blando).
 - Palpación cervical en busca de adenopatías duras.
3. **Documentar características de la lesión:** tamaño, color, induración, sangrado, ulceración, duración.
4. **Derivación inmediata** al especialista si:
 - Lesión oral o faríngea **>2–3 semanas** sin causa aparente.
 - Disfonía persistente **>3 semanas**.
 - Masa cervical indolora sin causa infecciosa.
 - Epistaxis recurrente unilateral.
 - Hipoacusia conductiva unilateral persistente (posible carcinoma nasofaríngeo).

4.2 En nivel especializado (segundo nivel o terciario)

- **Nasofibroscopía / laringoscopia flexible:** inspección directa de mucosa nasofaríngea y laríngea.
- **Biopsia incisional/excisional:** confirma el diagnóstico histológico.
- **PAAF** de adenopatías sospechosas.
- **TC o RM de cabeza y cuello:** determina extensión y estadificación TNM.

- **PET-CT:** en tumores avanzados o primarios ocultos.
- **Marcadores virales:** detección de ADN del **VPH** o **EBV**, útiles pronósticamente.

5. Derivación oportuna (según guías MINSAL y GES)

5.1 Criterios de derivación desde APS a nivel secundario

Situación clínica	Tipo de derivación
Úlcera o lesión oral que no cicatriza >2 semanas	Urgente (máx. 15 días)
Disfonía persistente >3 semanas sin causa infecciosa	Urgente (máx. 15 días)
Epistaxis unilateral recurrente o obstrucción nasal con masa	Urgente (máx. 15 días)
Adenopatía cervical dura, fija, indolora >2 cm	Urgente (máx. 15 días)
Sospecha de cáncer orofaríngeo o laríngeo	GES: Derivación priorizada inmediata

□ En Chile, el **GES “Cáncer oral y orofaríngeo”** garantiza atención en **máx. 30 días desde la sospecha clínica** hasta confirmación diagnóstica.

5.2 Circuito de derivación GES

1. **Detección en APS:** médico o dentista certifica sospecha (formulario GES).
2. **Ingreso al sistema GES:** derivación priorizada a ORL o cirugía máxilofacial.
3. **Diagnóstico confirmado por biopsia.**
4. **Comité oncológico:** define tratamiento (cirugía, radioterapia, quimioterapia).

6. Prevención secundaria y educación comunitaria

La prevención secundaria se basa en el **tamizaje oportuno y educación sanitaria**.

6.1 Tamizaje y vigilancia

- No existen pruebas de tamizaje poblacional universal.
- **Tamizaje clínico dirigido** en grupos de riesgo:
 - Mayores de 40 años fumadores o bebedores.
 - Pacientes con exposición laboral irritante.
 - Personas con antecedentes de leucoplasia, eritroplasia o VPH.
- Examen anual de cavidad oral y orofaringe en APS u odontología.

6.2 Educación del paciente y la comunidad

- Evitar tabaco y alcohol.
- Consultar por lesiones orales que **no cicatrizan >2 semanas**.
- Reconocer signos iniciales: ronquera persistente, sangrado, dificultad para tragar, masas cervicales.
- Fomentar vacunación VPH (niños y niñas 9–14 años).
- Promover higiene oral, dieta rica en frutas y verduras, y control dental regular.

7. Complicaciones y pronóstico

7.1 Consecuencias del diagnóstico tardío

- Necesidad de **cirugías radicales** (laringectomía total, glossectomía, mandibulectomía).
- Pérdida de funciones vitales: voz, deglución, respiración natural.

- Discapacidad permanente, traqueostomía definitiva, alteraciones estéticas.
- Mortalidad elevada: sobrevida <40% en estadios IV.

7.2 Beneficios del diagnóstico precoz

- Curación >80–90% en estadios I–II.
 - Posibilidad de tratamientos conservadores (láser, RT exclusiva).
 - Mejor conservación de voz, deglución y estética facial.
 - Menor costo sanitario y mejor calidad de vida.
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas clínicas

1. **Toda lesión oral o faríngea persistente >2 semanas** debe biopsiarse o derivarse.
2. **Disfonía >3 semanas en fumador o bebedor crónico** = cáncer laríngeo hasta demostrar lo contrario.
3. **Epistaxis unilateral + hipoacusia conductiva + masa cervical** = sospechar carcinoma nasofaríngeo.
4. **VPH** se asocia a cáncer orofaríngeo en **jóvenes no fumadores** con mejor pronóstico.
5. La **biopsia** es obligatoria para confirmar el diagnóstico; nunca tratar “empíricamente” lesiones persistentes.
6. En Chile, los **casos sospechosos de cáncer oral/orofaríngeo son GES**, con acceso garantizado a diagnóstico y tratamiento.
7. El **dentista** también cumple rol clave en la detección de lesiones orales precancerosas.

✗ Errores comunes

- Atribuir úlceras crónicas a “aftas recurrentes” o “trauma protésico”.

- No registrar ni cuantificar el consumo de tabaco/alcohol.
 - No examinar cavidad oral y cuello en fumadores crónicos.
 - Tratar “ronquera crónica” con antibióticos o corticoides sin estudio.
 - No considerar cáncer en pacientes jóvenes con VPH.
 - No activar ruta GES ante sospecha clínica.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **diagnóstico precoz** del cáncer de cabeza y cuello depende de la **sospecha activa en APS**.
2. **Signos de alarma:** úlcera oral persistente, disfonía >3 semanas, epistaxis unilateral, masa cervical dura.
3. **Derivación GES priorizada:** máxima demora de 15–30 días desde la sospecha.
4. **Biopsia** es esencial para confirmar el diagnóstico; no se debe retrasar por tratamientos empíricos.
5. **Educación, tamizaje y control del tabaco/alcohol** son pilares de prevención secundaria.
6. **VPH positivo** mejora el pronóstico y resalta la importancia de la **vacunación preventiva**.
7. La **pesquisa oportuna en APS salva vidas y preserva funciones esenciales** como la voz y la deglución.